



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM
PELAYANAN PENANGGULANGAN TUBERKOLOSIS
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

PROGRAM PELAYANAN PENANGGULANGAN TUBERKOLOSIS



RS PRIMA HUSADA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat TB serta potensi penularan yang tinggi, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan, menuntut adanya upaya penanggulangan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memiliki peran strategis dalam penanggulangan TB, mulai dari penemuan kasus secara dini, penegakan diagnosis yang cepat dan akurat, pemberian pengobatan yang tepat, hingga pencegahan penularan melalui penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Selain itu, rumah sakit juga berperan dalam pelaksanaan surveilans, pencatatan dan pelaporan kasus TB melalui sistem nasional, serta pemberian terapi pencegahan TB (TPT) pada kelompok berisiko.

Program kerja pelayanan penanggulangan TB ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan TB yang komprehensif, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta terintegrasi dengan program mutu dan keselamatan pasien.

Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan tuberkulosis melalui kegiatan yang meliputi:

1. Promosi kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan, penobatan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku sasaran yaitu pasien dan keluarga, pengunjung serta staf rumah sakit
2. Surveilans tuberkulosis, merupakan kegiatan memperoleh data epidemiologi yang diperlukan dalam sistem informasi program penanggulangan tuberkulosis, seperti pencatatan dan pelaporan tuberkulosis sensitif obat, pencatatan dan pelaporan tuberkulosis resistensi obat.
3. Pengendalian faktor risiko tuberkulosis, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis, yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberkulosis di rumah sakit pengendalian faktor risiko tuberkulosis, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis, yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberkulosis di rumah sakit
4. Penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis. Penemuan kasus tuberkulosis dilakukan melalui pasien yang datang ke rumah sakit, setelah pemeriksaan, penegakan diagnosis, penetapan klarifikasi dan tipe pasien tuberkulosis. Sedangkan untuk penanganan kasus dilaksanakan sesuai tata laksana pada pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian kekebalan. Pemberian kekebalan dilakukan melalui pemberian imunisasi BCG terhadap bayi dalam upaya penurunan risiko tingkat pemahaman tuberkulosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian obat pencegahan. Pemberian obat pencegahan selama 6 (enam) bulan yang ditujukan pada anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien tuberkulosis aktif, orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa tuberkulosis, populasi tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.



1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
4. KMK No.HK.01.07-MENKES-350-2017 tentang RS dan Balai Kesehatan Layanan Tuberkulosis Resistensi Obat;
5. PMK No.27 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan;
6. Kepdirjen Nomor Hk.01.07/MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/II/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.



1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program kerja Tim Tuberkulosis ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan kegiatan pelayanan penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan melalui kegiatan kredensial, pemeliharaan mutu profesi, serta pembinaan etika dan disiplin profesi.

2. Tujuan Umum

Tujuan dari pelaksanaan DOTS adalah menjamin kesembuhan bagi penderita, mencegah penularan, mencegah resistensi obat, mencegah putus berobat dan segera mengatasi efek samping obat jika timbul, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis di dunia.

3. Tujuan Khusus

- a. Menjamin kesembuhan bagi penderita.
- b. Mencegah resistensi obat.
- c. Mencegah putus berobat segera mengatasi efek samping obat jika timbul, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis di dunia.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

“Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

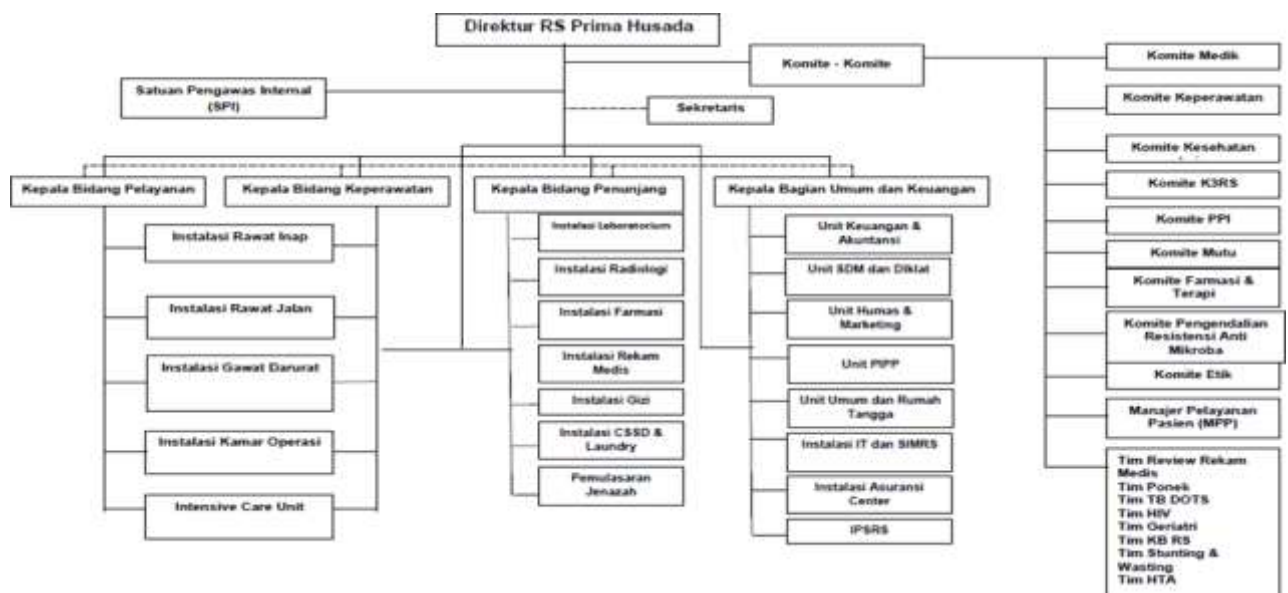
2.3 Motto

“Sahabat menuju sehat”

2.4 (7) Nilai Budi Utama

1. Jujur dipercaya
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



Gambar 1. Struktur Organisasi Rumah Sakit



**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO**

Tabel 2.5.1 Struktur Organisasi Tim Penanggulangan TB Rs Prima Husada Sukorejo

Ketua Tim	:	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P
Sekretaris	:	Irawati S.Kep.,Ns
Anggota		
1. Apoteker	:	Apt.Rohmah Madya Ayu Fitriana S.Farm
2. Perawat Rawat inap	:	Novita Febri Setiyani S.Kep., Ns
3. Perawat Poli paru	:	Citra Intan Pratiwi S.Kep.,Ns
4. Analis Kesehatan	:	Nikmatul khoriah A.Md.Kes

Keterangan :

1. Ketua Tim
 - a. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan maupun kepala instalasi yang terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan.
 - c. Mengendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi.
2. Perawat
 - a. Melakukan skrining pasien diawal masuk poli paru/ poli anak.
 - b. Melakukan cek penandaan pasien dengan diagnose TB pada RM .
 - c. Melakukan koordinasi dengan tim Pengendalian Tuberkulosis dan TimPPI dalam rangka kegiatan operasional.
 - d. Melakukan kegiatan-kegiatan operasional untuk pelayanan Pengendalian Tuberkulosis (pengawasan APD di poli paru/poli anak berupa pemakaian masker baik pasien maupun pengantar)
 - e. Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
 - f. Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Pengendalian Tuberkulosis termasuk pencatatan dan pelaporan
3. Apoteker
 - a. Melaksanakan pelayanan obat untuk Pengendalian Tuberkulosis.
 - b. Melakukan koordinasi dengan ketua tim Pengendalian Tuberkulosis dan tim medis lain.
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap kasus – kasus terkait obat pengendalian Tuberkulosis.
4. Analis Kesehatan
 - a. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium terkait pelayanan Pengendalian Tuberkulosis
 - b. Pemantauan pelaporan pelayanan Pengendalian Tuberkulosis terkait hasil analisa laboratorium.
 - c. Melakukan koordinasi dengan ketua tim Pengendalian Tuberkulosis terkait dengan pelayanan Pengendalian Tuberkulosis.



2.6 Permasalahan Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR		PERMASALAHAN	KET
		BERHASIL	TIDAK BERHASIL		
1.	Promosi Kesehatan	√		a. Keterbatasan media KIE b. Kurangnya penyuluhan rutin	
2.	Surveilans TB		√	a. Sering terlambat meninput data b. Keterbatasan SDM	
3.	Pengendalian faktor resiko TB		√	a. Skrining belum optimal b. Koordinasi antar unit kurang	
4.	Penemuan dan penanganan kasus TB a. Skrining TB b. Penemuan kasus TB c. Identifikasi Suspek TB d. Diagnosis TB e. Penegakan diagnosis f. Pemebrian pengobatan TB g. Monitoring pengobatan		√	a. Skrining belum maksimal b. Kesadaran pasien rendah c. Kepatuhan pasien dalam konsumsi obat OAT masih rendah d. Kurangnya penguatan PMO (pengawas menelan obat)	
5.	Pemberian kekebalan		√	a. Keterlambatan kunjungan bayi b. Edukasi pada orang tua kurang	
6.	Pemberian obat pencegahan		√	a. Skrining kontak belum optimal b. Kurangnya investigasi kontak aktif	
7.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	√		Penggunaan APD sudah terlaksana	
8.	Monitoring dan evaluasi program		√	a. Audit TB belum rutin b. Tindak lanjut perbaikan mutu kurang maksimal	

BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Tabel 3.1.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1.	Promosi Kesehatan (Promkes)	a. Memberikan edukasi pasien dan keluarga tentang TB b. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu c. Menyediakan media untuk KIE (poster dan leaflet)
2.	Surveilans TB	a. Mencatat kasus TB (suspek dan terkonfirmasi) b. Mencatat pelaporan melalui sistem nasional (SITB) c. Menganalisa data TB (tren kasus TB, angka keberhasilan pengobatan dan angka putus berobat)
3.	Pengendalian faktor risiko TB	a. Melakukan skrining kelompok risiko tinggi b. Memberikan edukasi perilaku
4.	Penemuan dan penanganan kasus TB a. Skrining TB b. Penemuan kasus TB c. Identifikasi Suspek TB d. Diagnosis TB e. Penegakan diagnosis f. Pemebrian pengobatan TB g. Monitoring pengobatan	a. Melakukan skrining TB (batuk lebih dari 2 minggu, demam , BB turun), skrining dilakukan di IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Skrining menggunakan form skrining TB b. Penemuan kasus secara pasif (pelayanan rutin) c. Penemuan kasus aktif (active case finding) d. Melakukan investigasi kontak erat e. Penetapan pasien suspek TB berdasarkan gejala f. Memberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan g. Penegakan diagnostik : dahak , TCM , rontgen thoraks h. Pemberian obat TB OAT sesuai standar nasional (strategi DOTS) i. Memonitoring pengawasan minum obat (PMO) j. Memonitoring efek samping obat
5.	Pemberian kekebalan	a. Menentukan sasaran (bayi baru lahir) b. Menyusun jadwal pelayanan imunisasi



		c. Pemberian vaksin BCG secara intradermal sesuai prosedur d. Penerapan prinsip keselamatan pasien (benar pasien, benar dosis, benar cara) e. Penerapan PPI (cuci tangan dan APD)
6.	Pemberian obat pencegahan TB	a. Melakukan skrining kontak erat pasien TB b. Pemberian Terapi Pencegahan TB (TPT) c. Memonitor kepatuhan dan efek samping TPT
7.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	a. Melakukan skrining TB di pintu masuk RS b. Menyediakan ruang Isolasi TB aktif (rawat inap) c. Penggunaan APD (masker N95) d. Ventilasi sudah baik di ruang pelayanan (rawat jalan) maupun di ruang isolasi (rawat inap) dan alur pasien TB e. Pengelolaan limbah medis TB f. Monitoring & audit PPI TB
8.	Monitoring dan evaluasi program	a. Melakukan audit kasus TB b. Evaluasi indikator mutu penemuan kasus Case Detection Rate (CDR) dan keberhasilan pengobatan Treatment Success Rate (TSR) c. Pencatatan dan pelaporan SITB d. Adanya tindak lanjut untuk perbaikan program

3.2 SASARAN

Tabel 3.2.1 Tabel Sasaran

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target / Standar	Indikator keberhasilan	Ket
1.	Promkes - Memberikan edukasi pasien dan keluarga tentang TB - Melakukan penyuluhan di ruang tunggu - Menyediakan media untuk KIE (poster dan leaflet)	- Meningkatkan pengetahuan pasien & keluarga - Mencegah penularan TB	- Seluruh pasien - Kelurga pasien - Pengunjung Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo	Promotif	- Terpenuhi dan tereduksi ≥80% kegiatan terlaksana	Jumlah pasien dan keluarga pasien yang tereduksi ≥ 90%	
2.	Surveilans - Mencatat kasus TB (suspek dan terkonfirmasi) - Mencatat pelaporan melalui sistem nasional (SITB) Menganalisa data TB (tren kasus TB, angka keberhasilan pengobatan dan angka putus berobat)	Mendapatkan data TB yang akurat	Semua kasus TB	Preventif	100% tercatat & dilaporkan	Laporan kasus TB di Rumah Sakit lengkap	
3.	Pengendalian faktor resiko - Melakukan skrining kelompok risiko tinggi - Memberikan edukasi perilaku	Dapat mendeteksi faktor resiko TB	Pasien TB (HIV , DM , dll	Preventif	≥90% terskrining	Pasien diskriming	



4.	Penemuan dan penanganan kasus TB a. Melakukan skrining TB (batuk lebih dari 2 minggu, demam , BB turun), skrining dilakukan di IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Skrining menggunakan form skrining TB b. Penemuan kasus secara pasif (pelayanan rutin) c. Penemuan kasus aktif (active case finding) d. Melakukan investigasi kontak erat e. Penetapan pasien suspek TB berdasarkan gejala f. Memberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan g. Penegakan diagnostik : dahak , TCM , rontgen thoraks h. Pemberian obat TB OAT sesuai standar	a. Menemukan suspek TB secara dini b. Menegakkan diagnosa c. Menentukan status TB pasien d. Memulai terapi tepat waktu e. Menyembuhkan pasien TB f. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat TB OAT g. Mencegah komplikasi pemberian terapi	Semua pasien suspek TB dan sudah terkonfirmasi positif TB	kuratif	a. 100% suspek TB tercatat b. 100% diagnosis sesuai standar dan pasien mendapat pengobatan TB OAT c. ≥90% pasien patuh d. 100% rujukan sesuai prosedur	e. Suspek tercatat dalam register f. Ketepatan diagnosis TB g. Pasien mulai pengobatan h. Patuhnya pasien dalam mmeminum obat i. Rujukan lengkap	
----	--	---	---	---------	---	--	--



	nasional (strategi DOTS) i. Memonitoring pengawasan minum obat (PMO) j. Memonitoring efek samping obat						
5.	Pemberian kekebalan a. Menentukan sasaran (bayi baru lahir) b. Menyusun jadwal pelayanan imunisasi	a. Menyediakan layanan imunisasi yang terencana dan cukup b. Memberikan kekebalan TB pada bayi	Bayi baru lahir	Preventif	≥95% cakupan BCG	Bayi menerima BCG sesuai jadwal	
6.	Pemberian obat pencegahan a. Melakukan skrining kontak erat pasien TB b. Pemberian Terapi Pencegahan TB (TPT) c. Memonitor kepatuhan dan efek samping TPT	Mencegah TB aktif	Kontak erat / ODHA	Preventif	≥80% mendapat TPT	Pasien patuh menjalankan TPT	
7.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) a. Melakukan skrining TB di pintu masuk RS b. Menyediakan ruang Isolasi TB aktif (rawat inap)	a. Mendeteksi dini pasien TB untuk mencegah penularan b. Mengurangi risiko penularan di RS	a. Pasien dan tenaga kesehatan b. Ruang pelayanan TB c. Lingkungan Rumah Sakit d.	Preventif Manajerial	a. 100% pasien diskriming b. 100% sesuai SOP c. 100% pasien diisolasi sesuai standar	a. Pasien terskrining TB b. Kepatuhan penggunaan APD c. Limbah dikelola dengan benar d. Laporan audit tersedia	



	c. Penggunaan APD (masker N95) d. Ventilasi sudah baik di ruang pelayanan (rawat jalan) maupun di ruang isolasi (rawat inap) dan alur pasien TB e. Pengelolaan limbah medis TB f. Monitoring & audit PPI TB	c. Melindungi tenaga kesehatan d. Menurunkan konsentrasi droplet TB e. Mencegah infeksi dari limbah f. Menjamin mutu PPI			d. 100% kepatuhan penggunaan APD e. 100% ventilasi sesuai standar f. 100% audit dilakukan		
8.	Monitoring dan evaluasi program a. Melakukan audit kasus TB b. Pencatatan dan pelaporan SITB c. Evaluasi indikator mutu penemuan kasus Case Detection Rate (CDR) dan keberhasilan pengobatan Treatment Success Rate (TSR) d. Adanya tindak lanjut untuk perbaikan program	a. Menyediakan data akurat untuk evaluasi b. Menjamin pelaporan tepat dan lengkap c. Menilai cakupan penilaian TB d. Menilai outcome terapi TB e. Meningkatkan mutu pelayanan TB	a. Tim TB Rumah Sakit b. Seluruh kegiatan program TB	Manajerial	a. 100% data terkumpul b. 100% tercatat dan dilaporkan c. $\geq 70\%$ CDR d. $\geq 90\%$ TSR e. 100% RTL dilaksanakan	a. Kelengkapan data b. Ketepatan dan kelengkapan data c. Laporan analisa tersedia d. Keberhasilan pengobatan e. Bukti tindak lanjut	

3.3 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 3.3.1 Tabel Cara Melaksanakan Kegiatan

No.	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti pelaksanaan	Ket
1.	Promosi kesehatan (Promkes)	a. Memberikan edukasi pasien dan keluarga tentang TB b. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu c. Menyediakan media untuk KIE (poster dan leaflet)	Edukasi dan penyuluhan serta konseling interpersonal	Leaflet dan poster	Harian	a. Leaflet dan poster tentang TB b. Daftar hadir c. foto saat mengedukasi serta foto saat penyuluhan	
2.	Surveilans TB	a. Mencatat kasus di register dan sistem SITB b. Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan	Dokumentasi dan pelaporan rutin	a. Format TB dan Komputer b. Aplikasi SITB	Kasus TB dicatat Harian, dan laporan SITB setiap bulan	a. Register TB b. Laporan bulanan	
3.	Pengendalian faktor resiko	Melakukan skrining HIV , DM , dan gizi	Skrining klinis	Format skrining	Harian	Format skrining TB	
4.	Penemuan dan penanganan kasus TB	a. Skrining batuk ≥ 2 minggu di semua unit b. Pemeriksaan dahak, TCM, rontgen c. Memberikan OAT sesuai standar d. Memantau kepatuhan & efek samping	a. Wawancara b. Pemeriksaan klinis c. Terapi langsung d. Observasi	a. Format skrining TB b. Alat Lab/ Radiologi c. Obat TB d. Buku kontrol	a. Skrining dan pemeriksaan dilakukan setiap hari kepa pasien baru yang terdapat gejala	a. Format skrining b. E-RM c. Hasil pemeriksaan d. catatan monitoring	



					b. Observasi dilakukan setiap bulan		
5.	Pemberian kekebalan	Memberikan vaksin BCG sesuai SOP	Tindakan medis	Vaksin BCG , ADS	Sesuai jadwal	Buku KIA, register imunisasi	
6.	Pemberian obat pencegahan	Memberikan obat pencegahan	Terapi	Obat TPT	Bulanan	Register TPT	
7.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	a. Memisahkan pasien TB dan menerapkan alur TB b. Penggunaan APD c. (masker N95) d. Ventilasi sudah baik di ruang pelayanan e. (rawat jalan) maupun di ruang isolasi (rawat inap) dan alur pasien TB f. Pengelolaan limbah medis TB g. Monitoring & audit PPI TB	Observasi dan kepatuhan	SPO PPI SPO APD APD	Harian	Checklist PPI Audit PPI SPO PPI SPO APD	
8.	Monitoring dan evaluasi program	a. Melakukan audit kasus TB b. Pencatatan dan pelaporan SITB c. Evaluasi indikator mutu penemuan kasus Case Detection Rate (CDR)	a. Rapat evaluasi program b. Diskusi	a. Format audit b. Laporan triwulan dan tahunan	Triwulan	Laporan triwulan Laporan tahunan	



		dan keberhasilan pengobatan Treatmen Succes Rate (TSR) d. Adanya tindak lanjut untuk perbaikan program					
--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 3.4.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	KEGIATAN	BULAN												Tempat	PIC	Sumber dana
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Promkes a. Memberikan edukasi pasien dan keluarga tentang TB b. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu c. Menyediakan media untuk KIE d. (poster dan leaflet)													RS	Petugas TB/promkes	
2	Surveilans a. Mencatat kasus TB (suspek dan terkonfirmasi) b. Mencatat pelaporan melalui sistem nasional (SITB) c. Menganalisa data TB (tren kasus TB, angka keberhasilan pengobatan dan angka putus berobat)													RS	Petugas TB	
3.	Pengendalian faktor resiko a. Melakukan skrining kelompok risiko tinggi b. Memberikan edukasi perilaku													RS	Dokter/ Perawat	



4.	Penemuan dan penanganan kasus TB a. Skrining batuk ≥ 2 minggu di semua unit b. Pemeriksaan dahak, TCM, rontgen c. Memberikan OAT sesuai standar Memantau kepatuhan & efek samping														RS	Dokter, Perawat, Petugas Lab dan Petugas Radiologi	
5.	Pemberian kekebalan a. Menentukan sasaran (bayi baru lahir) b. Menyusun jadwal pelayanan imunisasi														RS		
6.	Pemberian obat pencegahan a. Melakukan skrining kontak erat pasien TB b. Pemberian Terapi Pencegahan TB (TPT) c. Memonitor kepatuhan dan efek samping TPT														RS		
7.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)														RS		
8.	Monitoring dan evaluasi program a. Rapat evaluasi program														RS		

3.5 Kebutuhan Anggaran

3.5.1 Tabel Kebutuhan Anggaran

NO	BAHAN	RATA /BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN		HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1.	Leaflet dan poster	15	180	Lembar	1000	180.000
2.	ATK dan format TB	10	120	Set	5000	60.000
3.	Internet / data	1	12	Paket	30.000	360.000
4.	Format skrining	30	360	Lembar	1000	360.000
5.	Reagen lab	10	120	Paket	50.000	600.000
6.	OAT	20	240	Paket	0	0
7.	Vaksin BCG	10	120	Dosis	0	0
8.	Masker N95	30	360	Pcs	5.000	1.800.000
9.	Hand rub	1	12	Botol	30.000	360.000
10.	Rapat evaluasi	20	240	Porsi	25.000	300.000
					Total	4.020.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) program pelayanan Tuberkulosis (TB) merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai pelaksanaan program, pencapaian indikator, serta kualitas pelayanan TB di rumah sakit. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja program pelayanan TB dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

- 4.1 Monitoring dengan melakukan supervisi
- 4.1.1 Tabel Monitoring dengan melakukan supervisi

NO	Aspek yang di supervisi	Standard /Target	Sesuai Standar (V)	Tidak sesuai standar (V)	Catatan temuan
1.	Promosi Kesehatan (Promkes)	Edukasi ≥2x/tahun, dokumentasi tersedia			
2.	Surveilans TB	Pelaporan TB 100% lengkap & tepat waktu (SITB)			
3.	Pengendalian Faktor Risiko	Skrining faktor risiko (HIV, DM) ≥90%			
4.	Penemuan & Penanganan Kasus TB	CDR ≥70% TSR ≥90%			
5.	Pemberian Kekebalan (BCG)	Cakupan imunisasi ≥95%			
6.	Pemberian Obat Pencegahan (TPT)	Cakupan TPT ≥80%			
7.	Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI)	Kepatuhan APD ≥95–100%			
8.	Monitoring & Evaluasi Program	Rapat evaluasi ≥4x/tahun			

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan program pelayanan TB adalah kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan pelayanan TB, mulai dari penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, hingga pemantauan pasien. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data pelayanan TB lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaporan dilakukan sesuai standar nasional TB dan ketentuan akreditasi Rumah Sakit :

5.1 Pelaporan Internal

1. Disampaikan kepada kepala unit TB dan manajemen rumah sakit;
2. Meliputi jumlah kasus, kepatuhan pengobatan, cakupan imunisasi, dan pelaksanaan PPI;
3. Dilakukan bulanan dan triwulan.

5.2 Pelaporan Eksternal

1. Disampaikan ke Dinas Kesehatan / SITB sesuai format nasional;
2. Meliputi indikator kinerja utama ;
 - a. Case Detection Rate (CDR)
 - b. Treatment Success Rate (TSR)
 - c. Cakupan TPT
 - d. Cakupan imunisasi BCG
 - e. Kelengkapan laporan PPI dan Promkes
 - f. Dilakukan bulanan dan tahunan

BAB VI PENUTUP

Program kerja pelayanan Tuberkulosis di Rumah Sakit Prima Husada ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan pelayanan yang lebih baik

Mengetahui
Ketua Tim TB



dr. Novita Maulidiyah, Sp.P

Pasuruan, 01 Januari 2026
Perawat Penanggung Jawab
Tim TB



Citra Intan Pratiwi, S.Kep., NS

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M.Kep)